



Godoy. psicopatologia. De la psiquiatria al psicoanalisis

Psicopatología (Universidad de Buenos Aires)

Como se ve, la historia y situación actual de la psicopatología son complejas y problemáticas. Su campo se ha constituido como resultado de diferentes prácticas con referencias teóricas muy diversas. De ello se ha derivado una pluralidad de "psicopatologías", cada una con su fundamentación propia y un ordenamiento interno que le es específico, lo cual se traduce en sistemas de categorías clínicas y nomenclaturas no sólo disímiles sino difícilmente comparables entre sí al estar construidas en registros y con criterios dispares. Por último, debe agregarse que estas psicopatologías no siempre se suceden unas a otras sino que coexisten y se superponen muchas veces de manera desordenada, configurando una situación actual no sólo de amplia variedad sino de cierta confusión. Ello obliga a asumir ciertas decisiones para delimitar la orientación y contenido de la enseñanza de la psicopatología, especialmente haciendo explícitas las posiciones teóricas desde las que se la aborda.

La psicopatología: de la psiquiatría al psicoanálisis¹

Claudio Godoy

La historia no es el pasado, afirmaba una vez Jacques Lacan en su *Seminario 1*. En efecto, el pasado, conglomerado de hechos, fechas y nombres propios se distingue de la historia en tanto ésta es la lectura que *a posteriori*, desde el presente, ordena y da su razón de ese pasado. El pasado no cambia pero la historia que se cuenta de él siempre puede renovarse. Está abierta al hallazgo, a la sorpresa. Eso lo demuestra la experiencia misma de un psicoanálisis.

En este caso lo que nos ocupa es la historia de la psiquiatría y la psicopatología. No nos abocaremos a ella con un afán de erudición historicista. Nuestro interés, por el contrario, es ubicar el surgimiento y el despliegue de ciertos conceptos, de algunas entidades clínicas cuya vigencia prosigue en nuestros días, como así también de ciertas problemáticas y obstáculos que continúan interrogando a nuestro presente. Nos interesa también la tensión, los cruces, entre la psiquiatría, la psicopatología y el psicoanálisis. Lacan destacaba que hay una clínica desde que hay tipos clínicos. Esa clínica es anterior al psicoanálisis, es la que construyeron los clásicos de la psiquiatría identificando y nombrando una serie de tipos clínicos. Freud y Lacan los han usado: paranoia, demencia precoz, histeria, *amentia*, etc. son términos que provenían de la psiquiatría. Ahora bien, ese uso no ha sido sin consecuencias. Al ser retomados desde la clínica psicoanalítica no solo encuentran una elucidación nueva sino también una

¹ Una primera versión de este trabajo fue publicada en *Psicoanálisis y psiquiatría: encuentros y desencuentros*, Berggasse 19, Buenos Aires, 2002.

perspectiva que subvierte a la clínica que los forjó. La psicopatología es el campo a través del cual el psicoanálisis va a incidir también en la historia de la psiquiatría. Lo demuestra el modo en que los psiquiatras de Zurich (Bleuler, Jung) acogieron las concepciones freudianas para la creación del concepto de esquizofrenia.

Intentaremos entonces seguir una historia de la psiquiatría que nos permita situar algunas escansiones esenciales a los fines que proponemos, que nos permita precisar cuál ha sido el marco de la producción de ciertas nociones y cuáles han sido los *impases* que se han encontrado. Esto nos posibilitará captar mejor que los tipos clínicos no son especies naturales sino el recorte, producido en el campo de la clínica, a partir de ciertos conceptos que explícita o implícitamente, agrupan un conjunto de síntomas. Desde el empirismo descriptivo de la psiquiatría clásica, a los mecanismos freudianos o la concepción estructural lacaniana, resulta fundamental para una materia como psicopatología extraer cuál es el criterio y la lógica que opera en cada distinción nosológica. Solo desde allí puede sostenerse una clínica diferencial y la posibilidad de un diagnóstico.

Para que la historia no sea entonces una simple y tediosa colección de nombres y fechas se trata de producir la lógica que la rige. Esta lógica puede recorrerse en dos perspectivas distintas: una, nacida en el campo mismo de la psiquiatría, nos permitirá seguir cómo un psiquiatra historiza su disciplina; otra, desde la extraterritorialidad que permite el psicoanálisis y el concepto lacaniano de estructura, nos abrirá otra vía en la lectura de los autores clásicos. Ambas, sin ser antinómicas, son, sin embargo, diferentes. Trataremos entonces en el presente trabajo de recorrerlas y de interrogar algunas de estas diferencias.

Los paradigmas de la psiquiatría

Georges Lanteri-Laura (psiquiatra y profesor de Psiquiatría) ha propuesto –en una obra de reciente publicación (LANTERI-LAURA 1998)– la utilización del concepto de “paradigma” para realizar una lectura de la historia de la psiquiatría, desde sus orígenes hasta la actualidad. La noción de paradigma fue introducida en

el estudio de la historia y filosofía de la ciencia por T. S. Kuhn en su obra *La estructura de las revoluciones científicas*. Allí distinguía la “ciencia normal” (reconocida como fundamento de una práctica, aquella que nadie pone en cuestión y permite resolver los problemas que surgen en su campo) de la “ciencia en crisis”, acosada por problemas que no puede resolver. Un “paradigma” implica para Kuhn “que algunos ejemplos aceptados de la práctica científica real –ejemplos que incluyen, al mismo tiempo, ley, teoría, aplicación e instrumentación– proporcionan modelos de los que surgen tradiciones particularmente coherentes de investigación científica” (KUHN 1962, 34). El paradigma constituye el conjunto del saber establecido que sostiene a la ciencia normal en su función, opera como una referencia eficaz que permite resolver los problemas planteados en un campo científico dado. No se trata, por lo tanto, de una teoría en particular sino de un marco en el interior del cual son posibles un conjunto de teorías. La eficacia de ese paradigma se mantiene mientras no surjan problemas que lo pongan en crisis. El estado de crisis se mantendrá hasta el surgimiento de un nuevo paradigma y el establecimiento de una nueva forma de “ciencia normal”. Este concepto –surgido de la historia de la ciencia– es tomado por Lanteri-Laura para pensar la historia de la psiquiatría. Para este autor el paradigma “regula de manera coherente, eficaz, racional y económica la disciplina” (LANTERI-LAURA 1998, 38) en cuestión. Al planteo de Kuhn, Lanteri-Laura le hará dos rectificaciones para aplicarlo a la psiquiatría: 1) aclara que la constitución de un nuevo paradigma y una nueva ciencia normal no es sin un arrastre residual de ciertas concepciones provenientes del paradigma anterior, 2) introduce lo que podríamos llamar cierta dialéctica entre los paradigmas, en donde algunas nociones y problemas de un paradigma superado pueden permanecer “latentes”, llegando a manifestarse luego en otro. El pasaje de un paradigma al siguiente deja “res- tos” manifiestos durante un tiempo; es decir, permanecen nociones o criterios residuales del paradigma anterior, pero también se producen modos de retorno de cuestiones que parecían superadas o que permanecían veladas. El esquema resultante es una serie de tres paradigmas escandida por las crisis respectivas, teniendo en cuenta que las discontinuidades no son absolutas sino con “residuos” y “retornos”.

1° paradigma → CRISIS → 2° paradigma → CRISIS → 3° paradigma

Con este modelo aplicado a la psiquiatría G. Lanteri-Laura distingue tres paradigmas fundamentales: el de *la alienación mental*, el de *las enfermedades mentales* y el de *las grandes estructuras psicopatológicas*. Esto abarca una historia que va desde 1793 (la asunción de Pinel como director del asilo de Bicêtre) hasta 1977 (la muerte de H. Ey). Los dos primeros paradigmas corresponden, respectivamente, a los dos tipos de clínica que distinguiera P. Bercherie: sincrónica y diacrónica (BERCHERIE 1980). De todos modos la aplicación del concepto de paradigma le brinda a Lanteri-Laura una perspectiva que permite aislar y destacar algunos otros rasgos de dichos períodos que, a su vez, nos posibilitarán ubicar mejor el contexto de formación de la psicopatología y el momento en que ésta surge y se impone en el pensamiento psiquiátrico. Pasaremos a reseñar entonces estos dos primeros paradigmas para luego detenernos en el tercero y en el viraje crucial del segundo al tercero.

El paradigma de *la alienación mental* corresponde al pasaje de la noción social y cultural de “locura” al concepto médico de “alienación mental”. Podríamos ubicarlo como el paso fundacional de la psiquiatría que introduce la “locura” en el campo de la medicina con lo cual pasa a concebirla como una enfermedad. Esto permite en la práctica sustraerla de otros dispositivos –por ejemplo judiciales y policiales– para ubicarla en el plano de la asistencia médica. La alienación mental se constituye así en una especialidad autónoma, opuesta a todas las otras enfermedades de la medicina, y sus manifestaciones (manía, melancolía, demencia e idiotismo) no constituyen para Pinel –uno de los autores, junto a Esquirol, que caracteriza a este período– enfermedades irreductibles sino simples variedades que incluso pueden sucederse en el mismo paciente. Por lo tanto lo que se destaca aquí es el singular de “la” alienación mental. Sus variedades de presentación no le quitan el carácter de enfermedad única, para la cual se propone una única forma de tratamiento: el tratamiento moral de la locura. Por “moral” podría entenderse algo más próximo a lo que llamaríamos hoy en día “psicológico”, aunque sus presupuestos no dejan de tener fuertes componentes ideológicos “morales”, en el sentido más propio de este término. Es en

este período que surge el dispositivo de la internación como una parte esencial del tratamiento moral. Dicho dispositivo se erige bajo la suposición de que aislar al alienado de sus lazos familiares y de los problemas del mundo evita las pasiones que agravan la alienación mental; a su vez el “asilo” encarnaría un ambiente enteramente racional que podría devolverle la razón al alienado. El tratamiento moral buscaba luego, a través de este aislamiento, dirigirse a lo que “restaba” de razón en el alienado y ocuparlo en un trabajo que pudiera alejarlo de su padecimiento.

La “crisis” de este paradigma puede ser ubicada a mediados del siglo XIX a partir de la obra de J. P. Falret (1749-1870), un alumno de Esquirol, que sostuvo que, lejos de tratarse de una enfermedad única, la patología mental se componía de una serie de especies mórbidas. Según su criterio éstas no constituían meras variedades sino que serían específicas e irreductibles unas a otras. Para Falret: “La práctica de una semiología y de una clínica atentas y prologadas, cuidadosa a la vez de la precisión en la actualidad y del cuidado en la evolución, conduce a identificar especies mórbidas que no se pueden reducir a la unidad sin desconocer la riqueza de los datos de la observación...” y concluye que ellas son “especies verdaderamente distintas, caracterizadas por un conjunto de síntomas y por una marcha determinada” (LANTERI-LAURA 1998, 97).

El trabajo de Falret introduce la crisis de la noción de alienación mental y sienta las bases sobre la que se construye el paradigma de “las” *enfermedades mentales*. Destacamos entonces, siguiendo la propuesta de Lanteri-Laura, el plural (“las”) en contraposición a “la” alienación mental. Este nuevo paradigma llevará a poner el acento en la semiología y en la observación clínica del paciente, ya que al multiplicarse las entidades mórbidas se vuelve crucial la evaluación diagnóstica. Cuando se trataba de *la alienación mental* bastaba con distinguir a esta de otras enfermedades del campo de la medicina y, una vez reconocida, sólo había una modalidad de tratamiento (el tratamiento moral). Al constituirse la patología mental como un conjunto de enfermedades distintas, con sus signos propios y sus modos singulares de evolución se requería reconocer sus signos. Es así que se despliega la “semiología” psiquiátrica en su máxima riqueza para poder establecer un pronóstico y un tratamiento adecuado. La

semiología, desde el siglo XVIII constituye una rama de la medicina que se ocupa de describir y definir los signos de las enfermedades. La semiología psiquiátrica –construida a partir de ese modelo médico– pasa a ocuparse de “los síntomas que el enfermo manifiesta espontáneamente, los signos que el psiquiatra debe buscar y discriminar, y de los síndromes, asociaciones más o menos específicas de síntomas y signos, que reenvían a una clasificación, a una nosografía que el clínico ha aprendido a reconocer” (POSTEL 1994, 511).

Esto produce un desarrollo marcado de la clínica, la constitución de los grandes nosografías y de un *thesaurus* semiológico cuyo valor perdurará hasta nuestros días. La observación atenta y la descripción constituyen lo que Lanteri-Laura llama “empirismo estricto”: el que hace valer la observación por oposición a los presupuestos, es decir, la clínica como distinta y opuesta a la psicopatología. Para este autor se establece así una tensión entre la clínica y la psicopatología en el curso de la historia de la psiquiatría que –como veremos– se refleja luego en el pasaje del segundo al tercer momento.

La crisis de este paradigma comienza a producirse en el punto en que la multiplicación de las especies mórbidas se torna difícil de ordenar. Es el momento también en que surge el cuestionamiento de la teoría de las localizaciones cerebrales en donde se ponían las esperanzas para anclar a las enfermedades mentales en una etiología certera. Pero, fundamentalmente, será el surgimiento de la obra de S. Freud y su incidencia en psiquiatras como Bleuler en Zurich las que introducirán las bases para la constitución del tercer paradigma de la psiquiatría.

Las grandes estructuras psicopatológicas

La psicopatología no nace con el tercer paradigma. Por el contrario ella tiene su propia historia. Lo que se destaca en el tercer paradigma es el momento en que un conjunto de conceptos y la psicopatología misma se imponen en el ámbito de la psiquiatría, produciendo una modificación crucial de sus coordenadas. Ubiquemos entonces primero esta historia propia de la psicopatología.

El término “psicopatología” fue utilizado por primera vez por el alemán Emminghaus en 1878 pero como equivalente a psiquiatría clínica. La psicopatología nace más tarde como método y disciplina propia. Es el francés Théodore Ribot (1839-1916) quien crea el “método patológico” que buscaba comprender la psicología normal a partir del estudio del hecho patológico. Constituía una especie de psicología patológica como rama de la psicología científica simultáneamente con la psicología experimental de la cual se distinguía. Para Ribot la enfermedad era una experimentación sutil producida por la naturaleza misma que brindaba un campo de estudio privilegiado. Su formación era filosófica y no tenía una práctica concreta en el campo de la patología mental. La psicopatología constituía entonces una disciplina fundamentalmente teórica opuesta a la psiquiatría como práctica médica. Un discípulo de Ribot, Pierre Janet (1851-1947), originariamente también de formación filosófica, se volcará luego a la medicina y será uno de los fundadores de la psicopatología dinámica. De este autor destacará Lacan, en su tesis de 1932, la importancia de sus “trabajos sólidos” y lo llamará “un pionero de la psicopatología”. Siguiendo los principios de Ribot en el empleo del método patológico introducirá la noción de una estructuración de tipo evolutiva del aparato psíquico. Esta noción se basaba en las concepciones de Spencer y Hughlings Jackson que concebían la patología como una desestructuración que va en el orden inverso de la evolución jerárquica de las funciones. Janet sostendrá un ríspido debate con Freud y será uno de sus principales oponentes en Francia. Prefirió utilizar la noción de “subconsciente” y trazó una nosografía que, desconociendo la oposición entre neurosis y psicosis, destacó la distinción entre histeria y psicastenia. Los trabajos de Janet serán luego retomados por Henri Ey para la elaboración de su modelo órgano-dinámico.

Si la psicopatología francesa comienza en la filosofía y la psicología especulativa y luego se inserta en el campo de la psiquiatría, en Alemania sigue un camino inverso. Esto queda puesto en evidencia en la singularidad de K. Jaspers, quien primero como psiquiatra escribe su monumental *Psicopatología General* (JASPERS 1913) para luego, a partir de los años 20, pasar de la práctica psiquiátrica a la filosofía. Jaspers opone la psiquiatría como “profesión práctica” a la psicopatología como “ciencia”. “En la

profesión psiquiátrica práctica, se trata de los seres humanos individuales y enteros, ya sean puestos a disposición del psiquiatra para la custodia, la atención y la curación, o haya de hacer un peritaje, etc... el psicopatólogo [en cambio] queda en el dominio de los conceptos y las reglas generales" (JASPERS 1913, 15). Para Jaspers el objeto de la psicopatología es "saber qué y cómo experimentan los seres humanos, queremos conocer la dimensión de las realidades anímicas...Sin embargo, no es nuestro objeto todo acontecimiento psíquico, sino sólo el patológico" (ibíd., 16). Así establece una fenomenología entendida como un procedimiento empírico mantenido en marcha por la comunicación por parte del enfermo; por ejemplo cuando afirma que "sólo por los enfermos nos son comunicados los fenómenos patológicos más esenciales" y agrega "Las autodescripciones psicóticas no sólo son insustituibles, sino que dan también muchos resultados dignos de confianza. Los enfermos fueron los descubridores de muchos conceptos básicos" (ibíd., 76). Propone así estudiar los estados tal como los enfermos los experimentan, sus confidencias y sus escritos ya que son el material "más precioso para representarse lo que pasa realmente en la enfermedad" (BEAUCHESNE 1986, 179). Es por ello que afirma que el estudio de un solo caso en profundidad revela mucho más que innumerables casos poco profundizados. Este tipo de estudio le permitirá distinguir los fenómenos "comprensibles", como *desarrollo* de la personalidad y de la biografía del paciente, de aquellos que están en ruptura con la personalidad previa, en discontinuidad, y son calificados de *proceso*.

Lanteri-Laura ubica el surgimiento del paradigma de las grandes estructuras psicopatológicas en 1926, en la intervención de Bleuler en el Congreso de Psiquiatría de Ginebra y fecha su declinación en 1977, año de la muerte de Henri Ey. La elección del año 1926 para fechar la constitución de este paradigma, y no en la redacción del texto sobre la esquizofrenia de Bleuler (1908, o su publicación en 1911), es porque el Congreso de alienistas y neurólogos de lengua francesa, realizado en 1926, marca la aceptación y consolidación de la perspectiva bleuleriana en el plano internacional. Por su parte, el modelo órgano-dinámico de H. Ey implicará el último esfuerzo por constituir un sistema que de su razón a la psiquiatría en su totalidad. Por lo tanto identifica con la muerte de este autor el ocaso del tercer paradigma.

Cabe aclarar que la noción de estructura que manejó la psiquiatría entre los años 20 y 40 tuvo su origen fundamentalmente en la teoría de la forma (*Gestalt*), la cual realizó una severa crítica a los métodos y conclusiones de la psicología experimental alemana, cuyo máximo exponente fue Wundt. Vale la pena recordar que fue con Wundt con quien comenzó su trabajo Kraepelin (exponente de la culminación del segundo paradigma), y que la semiología de este último se basó, en gran medida, en las concepciones psicológicas de su maestro. La teoría de la forma destacaba el valor operatorio de una organización de elementos irreductibles a la suma de sus partes. Autores como Koehler y Koffka intentaron demostrar que el mínimo perceptible para un ser vivo no es jamás un estímulo aislado y absoluto sino una organización figura-fondo. Esto también se enlazó con la neurología globalista que, oponiéndose a la teoría de las localizaciones, concebía al cerebro como una totalidad articulada, es decir como una estructura figura-fondo. También cobra un lugar destacado la filosofía fenomenológica que ejercerá, durante esa época, una amplia influencia tanto en la psiquiatría alemana como francesa.

La oposición entre neurosis y psicosis se impondrá en este momento. Esta distinción —proveniente del psicoanálisis— le permitirá a la psiquiatría organizar todo lo que no corresponde a lesiones cerebrales evidentes ni a factores exógenos indudables. Según Lanteri-Laura esta distinción tratará de ser sostenida por la psiquiatría apoyándose también en la neurología globalista y la filosofía fenomenológica. Esto le permitirá al paradigma de las grandes estructuras mantener tanto una distinción de origen más psicopatológico que clínico como conservar, al mismo tiempo, el valor pragmático de la exigencia de totalidad del campo de la psiquiatría.

Para Lanteri-Laura con la prevalencia de la noción de estructura la relación entre psiquiatría clínica y psicopatología se va a invertir completamente, "La psiquiatría clínica pasará a segundo plano, como una disciplina médica inevitable, pero muy empírica y carente de amplitud, limitada a tareas útiles pero sin envergadura ni preocupación antropológica, apuntando a establecer un diagnóstico y a conducir un tratamiento... La psicopatología, al contrario, devendrá dominante y la psiquiatría clínica repre-

sentará solamente una aplicación un poco derivada" (LANTERI-LAURA 1998, 180).

Tal como señalamos, uno de los autores que marca el punto de crisis del paradigma de las enfermedades mentales y el pasaje a las grandes estructuras psicopatológicas es E. Bleuler. Resulta entonces importante diferenciar las perspectivas de Kraepelin y Bleuler; mientras el primero, con su concepción sobre la demencia precoz se encuentra de lleno en el segundo paradigma; Bleuler marca el pasaje del segundo al tercero al introducir e imponer su concepto de esquizofrenia. Para Kraepelin, la demencia precoz constituía una enfermedad que podía ser abordada a partir de la descripción clínica y cuya evolución asegura su unicidad. Bleuler, por el contrario, "se sitúa en otra perspectiva, donde la clínica se inspira en concepciones no clínicas, de la cual ella deriva en su mayor parte" (ibíd., 138). Es decir, Bleuler introduce hipótesis psicopatológicas y no meramente descriptivo-semiológicas, poniendo en cuestión el valor del paradigma de las enfermedades mentales. Esto traerá aparejado una progresiva "reducción" de las enfermedades mentales junto con la ampliación del concepto de esquizofrenia hasta cubrir casi todo el campo de la psicosis y, por consiguiente, comenzar a relegar al olvido a la paranoia.

Un conjunto de jóvenes psiquiatras conformaron, en los años 30, el grupo *L'évolution psychiatrique*. Entre ellos se encontraba el joven J. Lacan, junto a H. Ey y E. Minkowski. Este último –seguidor de Bleuler– introdujo una crítica de la psiquiatría (del segundo paradigma) que marca muy bien la posición de los autores que corresponden al tercer paradigma: "La psiquiatría objetiva es insuficiente y no permite analizar los elementos más que como elementos psíquicos artificialmente aislados, a los que se atribuye falsamente una realidad propia" (MINKOWSKI 1933, 208). Por el contrario, desde la perspectiva psicopatológica que propone este autor "El síndrome mental no es para nosotros una simple asociación de síntomas, sino la expresión de una modificación profunda y característica de la personalidad humana entera" (ibíd., 209). Así propone como ejemplo: "las preocupaciones hipocondríacas de un ansioso y las ideas hipocondríacas de un esquizofrénico se presentan como manifestaciones de naturaleza semejante, porque el fondo mental es, en los dos casos, del todo diferente... Sucede lo mismo... con las obsesiones verdaderas o

las pseudobsesiones de naturaleza esquizofrénica. Esta similitud en la expresión de perturbaciones totalmente desemejantes no debería sorprendernos. El número de conceptos de que disponen los enfermos para expresar sus estados de alma es forzosamente limitado; y recurren con gran facilidad a las mismas ideas, para llenar el vacío que se ahonda en ellos" (ibíd., 210). El diagnóstico estructural consistirá, para Minkowski, en la identificación del *trastorno generador* que corresponde –según su concepción– a lo que es la base anatómofisiológica de los síndromes somáticos. Afirma así que "no tendremos que vérnoslas aquí con órganos, ni con funciones, sino con la personalidad viviente, una e indivisible" (ibíd., 209). Siguiendo el camino de Clérambault y su automatismo –a quien critica la concepción etiológica organicista– propone que todos los síntomas que forman el síndrome del automatismo mental no serían sino diversas manifestaciones de una "única modificación subyacente a la personalidad humana" (ibíd., 205). En este caso se trataría de una singular relación de la personalidad con el espacio: los pensamientos y actos del sujeto son repetidos, raptados o impuestos a distancia, desde "afuera"; esta alteridad es lo que Minkowski denomina el factor "espacial". Para este autor encontrar que todos los síntomas de una entidad nosológica remiten a un mismo "trastorno generador", lo cual permitiría situar los síntomas en un análisis estructural. Resulta así un intento valioso en sí mismo aunque presenta el límite de su concepto de "estructura" pensado fenomenológicamente como "estructura de la personalidad". Podríamos afirmar, por lo tanto, que uno de los problemas centrales del tercer paradigma es qué se entiende por "estructura".

A su vez, el órgano-dinamismo de H. Ey –último en dotar a la psiquiatría de sistematicidad y homogeneidad– propone, siguiendo a Jackson y Janet, un orden jerárquico y dinámico de instancias superiores e inferiores. Lo superior contiene e integra a lo inferior, así como lo normal contiene a lo patológico potencial. En lo superior ubica a la consciencia que debe conducir y dominar todas las funciones inferiores que son automáticas e "inconscientes", las cuales aprovecharían cualquier descenso de su actividad para escapar a su control. El psiquismo queda equiparado así a la consciencia en su función regulativa y adaptativa. Todo proceso patológico daría por resultado dos tipos de síntomas: los

“negativos”, que son el resultado de la disolución de la función superior, y los “positivos” consecuencia de la liberación de los niveles inferiores. Es a este dinamismo entre instancias jerárquicas al que H. Ey llama “estructura” y deduce una estratificación de los estados psicopatológicos según el grado de degradación –en orden creciente– de la actividad psíquica. Así por ejemplo las estructuras neuróticas implicarían el nivel de degradación más leve y las demencias el más grave. El modelo de Ey es organicista porque atribuye la acción determinante a un proceso cerebral o somático, pero quiere distanciarse del mecanicismo –que concibe esa acción de un modo local y directo– postulando un juego dinámico de fuerzas que operan entre la desorganización y la reorganización en el nivel inferior de la actividad afectada. Para Ey “la psiquiatría no tiene por objeto todas las variaciones de la vida psíquica sino solamente aquellas que son *patológicas* porque representan el desorden, el desequilibrio, la regresión introducida al nivel de la consciencia y de la personalidad por los procesos mórbidos orgánicos... Las enfermedades mentales son insultos y trabas, no son causadas por la actividad libre, es decir puramente psicogenética. Admitir este punto de vista, es admitir que pueda haber una psiquiatría, rechazarlo es negar la posibilidad misma de una ciencia psiquiátrica” (EY 1950, 20). Se puede advertir fácilmente en este párrafo cómo intenta fundar el campo mismo de la psiquiatría en su singular concepción del organicismo. Para Ey la psicogénesis es la normalidad, la consciencia en su funcionamiento libre y adaptativo; lo patológico son los diversos grados posibles en que ese funcionamiento “libre” puede verse entorpecido, trabado, por una incidencia de lo orgánico. En síntesis: su concepción “estructural” es de tipo *gestaltista*, con la cual cree superar al organicismo mecanicista, realizando una juntura entre los trabajos del neurólogo H. Jackson (teoría de la disolución de las funciones) con una concepción fenomenológica (teoría de la consciencia).

La crisis del paradigma estructural se debe en parte a lo abusivo de la utilización del concepto de estructura que, al ganar amplitud, perdió precisión; luego a una declinación, en el nivel práctico, de las nociones introducidas por estas concepciones. “Un psiquiatra de la clase de P. Guiraud... estimaba que la noción de enfermedad mental permanecía empíricamente sólida y

que una cierta fragmentación tenía al menos un valor operativo” (LANTERI-LAURA 1998, 191). Es también el cambio introducido por el surgimiento y la multiplicación de los psicofármacos así como la diversidad de dispositivos psicoterapéuticos las que introducen nuevos problemas prácticos que ponen en cuestión al paradigma de las grandes estructuras. “Las referencias psicopatológicas se han multiplicado –sostiene Lanteri-Laura–, sin que ninguna de entre ellas se haya podido imponer a las otras, y al psicoanálisis, la psiquiatría dinámica y la fenomenología, se han agregado el conductismo, las teorías de la comunicación digital y analógica, las concepciones cognitivistas y ciertas importaciones de la inteligencia artificial, sin olvidar por otra parte las generalizaciones que no han dejado de realizarse a partir de los efectos terapéuticos de los neurolépticos, los ansiolíticos y los timolépticos. Ninguna de esas vías ha logrado, sin embargo, suplantarse a las otras... Al mismo tiempo la distancia que separa la actividad cotidiana, clínica y terapéutica, de las teorizaciones ha aumentado mucho... y carecemos completamente de una *teoría de la práctica* capaz de dar cuenta de manera reflexiva de esas prácticas mismas” (ibíd., 207). Es así que el autor que comentamos se pregunta si la autoridad de hecho adquirida por el DSM bastará para establecer, con su modelo sindrómico, un nuevo paradigma (el cuarto).

La vía que lleva a los DSM fue abierta por la concepción sindrómica de K. Schneider, un discípulo de Jaspers que introdujo la noción de *síntomas de primer orden*. Cada síndrome posee algunos síntomas que pueden servir para el diagnóstico –por ejemplo los once signos de la esquizofrenia–, éstos no reenvían a ningún proceso conocido pero adquieren todo su valor diagnóstico del consenso producido entre los clínicos competentes. Así se deja de lado la etiología y la evolución misma (ambas nociones de carácter psicopatológico) es relativizada. Según Schneider “la decisión de calificar a un síntoma como esquizofrénico no ha de adoptarse de modo personal y subjetivo, sino a ser posible de acuerdo con otros observadores” (SCHNEIDER 1950, 179), para concluir finalmente “yo no puedo afirmar esto es una esquizofrenia, sino: a esto denomino yo esquizofrenia; o bien esto es lo que se designa corrientemente, en la actualidad, como esquizofrenia” (ibíd., 179). Es fácil notar en estas afirmaciones la diferencia con

el tercer paradigma –por ejemplo la búsqueda del “trastorno generador” de Minkovski–, en ellas toda consideración etiológica –que no sea orgánicamente comprobable– es puesta entre paréntesis, ya no hay ninguna “estructura” que dé su lógica al conjunto de síntomas. En su lugar viene el “consenso” y la “actualidad”.

Lanteri-Laura considera, sin embargo, que la fragmentación progresiva y la pérdida de homogeneidad de la psiquiatría contemporánea resulta un obstáculo mayor a la hora de identificar un cuarto paradigma, aunque no podría concluirse su inexistencia del hecho que no sepamos nada de él.

El “paradigma” lacaniano

Tomando una mayor distancia de los planteos de Lanteri-Laura podemos destacar algunas aproximaciones y diferencias entre el psicoanálisis y el movimiento que gira en torno al tercer paradigma en la historia de la psiquiatría.

El psicoanálisis ha jugado un papel determinante en el pasaje del segundo paradigma al tercero: tanto por las hipótesis psicopatológicas que Freud introduce, que tendrán una incidencia en la psiquiatría a través de Bleuler, como por la distinción entre neurosis y psicosis. Sin embargo, el modelo construido en el tercer paradigma sigue estando dentro del campo de la psiquiatría. Una psiquiatría ya impactada por las concepciones freudianas pero a la que se le unen –como destacamos– la fenomenología, la teoría de la forma, la neurología globalista, entre otras; o que convergen en el modelo órgano-dinámico de H. Ey, el cual intentaba reunir estas diversas referencias para armar con ella un sistema que brinde un soporte teórico a la práctica psiquiátrica. Podríamos ubicar los trabajos de J. Lacan –incluso desde su época psiquiátrica– en una búsqueda que, si bien comienza en el seno del tercer paradigma lo articula de un modo singular con el segundo, en especial a partir de introducir un concepto de estructura radicalmente diferente. Este pasará a estar referido a la estructura del lenguaje y buscará articular a dicha estructura el efecto subjetivo. Un hito crucial que marca las diferencias entre el psicoanálisis y la psiquiatría (del tercer paradigma) lo consti-

tuye el debate que mantiene J. Lacan con H. Ey. Este debate tuvo lugar en el segundo coloquio de Bonneval en 1946, dedicado a *La psicogénesis de las neurosis y las psicosis*. Vemos que el título mismo se ubica bien en la égida de las “grandes estructuras psicopatológicas” tanto porque se centra en la oposición neurosis-psicosis como por la discusión psicopatológica que evoca la consideración de la psicogénesis. La ponencia de J. Lacan, titulada *Acerca de la causalidad psíquica* realiza un desmontaje crítico del modelo órgano-dinámico de H. Ey. Demuestra que éste no deja de tratarse de un organicismo –por más dinámico y alejado del mecanicismo que se declare– proponiendo, a su vez, una concepción radicalmente distinta de la locura, la causalidad y el problema de la libertad, central –como hemos señalado– en la concepción de H. Ey. Ubicamos aquí un punto de ruptura –que hemos desarrollado en otro trabajo²– entre la concepción más sistematizada que produce la psiquiatría del tercer paradigma y la orientación lacaniana del psicoanálisis que comienza a perfilarse a mediados de los 40’ y extraerá la dimensión estructural, a partir de la estructura del lenguaje, en los años 50’.

Si el segundo paradigma ponía su acento en el fenómeno clínico y el tercero destacaba la dimensión de la estructura, Lacan propone en lugar de esa disyunción –que es la que lleva al atolladero a los teóricos de las grandes estructuras– una conjunción: buscar la estructura en el fenómeno. Ya en su tesis se ubica un poco a contracorriente de su época. En una época que comienza a relegar la paranoia él centra su trabajo en la *paranoia de autopunición*. También se proponía buscar las “estructuras conceptuales” que se imponen en el sistema del delirio paranoico y que inciden en la percepción de la interpretación delirante.

El modo en que Lacan lee a los autores clásicos lo llevará a poner el acento en la estructura formal del síntoma. Es así como destaca en *De nuestros antecedentes* que el automatismo mental de Clérambault –un organicista mecanicista denostado por H. Ey– “con su ideología mecanicista de metáfora, muy criticable sin duda, nos parece, en su manera de abordar el texto subjetivo, más cercano a lo que puede construirse por un análisis

² Cf. “El debate de J. Lacan con H. Ey. Psicoanálisis y psiquiatría”, en este volumen.

estructural que ningún esfuerzo clínico en la psiquiatría francesa" (LACAN 1966a, 59). Es decir, para Lacan el estudio por Clérambault del "automatismo mental" –más allá de su etiología organicista y mecanicista– presenta un valor singular al aislar la estructura presente en el síntoma, aquello que Lacan luego definió como el significante en lo real de la psicosis.

Ahora bien, en los años 60 Lacan diferencia el "sujeto del significante" del "sujeto del goce" en la *Introducción a las Memorias de Schreber*. Introduce "la polaridad, la más reciente a ser promovida en ella, entre el sujeto del goce y el sujeto que representa el significante para un significante siempre otro ¿no es acaso esto lo que nos permitirá una definición más precisa de la paranoia como identificando el goce en ese lugar del Otro como tal?" (LACAN 1966b, 30). Esta búsqueda de Lacan por precisar las distintas localizaciones y tratamientos del goce en la estructura constituyen su modo de operar sobre el problema freudiano de los destinos de la libido.

Si el gesto inaugural que lleva al tercer paradigma es el trabajo –influido por Freud– de Bleuler sobre la esquizofrenia, al ubicar entre los síntomas fundamentales al autismo revela también cual es su límite. Concepto producido al borrar –tal como ha destacado P. Bercherie– las huellas del autoerotismo freudiano. Esta elisión del *eros* es la huella del rechazo de Bleuler de dar cuenta del goce en la clínica de la psicosis. Podemos encontrar cómo el mismo Freud subraya este problema en su *Contribución a la historia del movimiento psicoanalítico*: "yo tenía por norte una teoría de las neurosis basada en la libido, que se proponía explicar todas las manifestaciones así neuróticas como psicóticas, partiendo de destinos anormales de la libido... Este punto de vista faltó a los investigadores suizos" (FREUD 1914, 28). Es esta teoría de la libido la que le permite a Freud introducir la oposición neurosis-psicosis, así como la diferencia entre esquizofrenia y paranoia por los modos diferentes de tratamiento, localización y retorno de la libido retirada de los objetos. La hipocondría, el lenguaje de órgano, las alucinaciones y las distintas formas de delirio no se agotan en un plano descriptivo o formal sino que son modos, nombres del goce y sus elaboraciones en la psicosis, permitiendo distinguir sus destinos y tratamientos (intentos de curación) espontáneos.

Podríamos afirmar que la psiquiatría excluye el campo del goce, mientras que para el psicoanálisis la consideración de la envoltura formal del síntoma –sea neurótico o psicótico– es inseparable de la problemática de goce que implica. A su vez el psicoanálisis constituye una clínica bajo transferencia, introduce al analista –como Velázquez en "Las Meninas"– dentro del cuadro que pinta. Esto lo aleja de la descripción objetivante de la psiquiatría introduciendo la posición subjetiva de aquel que nos habla de los fenómenos que lo habitan.

Podemos afirmar que si bien el tercer paradigma de la psiquiatría no se constituye sin el psicoanálisis, éste, sin embargo, no se confunde con él. El tercer paradigma sigue siendo *de la psiquiatría*. Llamativamente desde el punto de vista de la perspectiva de Lacan, la consideración estructural fue más precisa en autores pertenecientes al segundo paradigma –Clérambault y Guiraud, por ejemplo– que los del tercero –H. Ey– extraviados en el gestaltismo, el evolucionismo jacksoniano y la fenomenología.

Esto nos permite ubicar a la psicopatología en una perspectiva distinta a la señalada por Lanteri-Laura. A este autor le interesa marcar el momento en que la psicopatología se impone en el pensamiento psiquiátrico a partir de la distinción de las grandes estructuras y de la creación de "sistemas" como el modelo órgano-dinámico. Desde la perspectiva del psicoanálisis, en cambio, resulta fundamental subrayar –como lo ha destacado R. Mazzuca¹– que los trabajos de Freud son decisivos en la constitución del campo de la psicopatología al introducir la formulación de hipótesis sobre la formación de síntomas. Esto lo lleva adelante ya desde sus tempranos trabajos, por ejemplo cuando afirma que "En un breve ensayo publicado en 1894 he reunido la histeria, las representaciones obsesivas, así como ciertos casos de confusión alucinatoria aguda, bajo el título de *neuropsicosis de defensa*, porque se había obtenido para estas afecciones un punto de vista común, a saber: ellas nacían mediante el mecanismo psíquico de la *defensa* (inconsciente)..." (FREUD 1896, 163). Aquí vemos como

¹ Cf. Mazzuca, R. "La invención freudiana de la psicosis" en Mazzuca, R. "La invención freudiana de la psicosis" en *Las psicosis. Fenómeno y estructura*, EUdeBA, Buenos Aires, 2001.

Freud reúne en una misma categoría clínica (la neuropsicosis de defensa) entidades muy distintas (nada menos parecido descriptivamente que una conversión histérica y una representación obsesiva, por ejemplo) porque la hipótesis psicopatológica del mecanismo psíquico de la defensa le brinda “un punto de vista común.” Vemos entonces cómo lo psicopatológico subvierte el plano de lo descriptivo: reúne lo distinto, diferencia lo parecido. Este es un procedimiento que reencontraremos a lo largo de la obra freudiana aunque complejizándose con otras dimensiones conceptuales (las construcciones metapsicológicas, la teoría de la libido, la segunda tópica, etc.). Por otra parte Freud inaugura un campo inédito, el llamado por él *psicopatología de la vida cotidiana* en el que aborda los mecanismos de las operaciones fallidas y casuales como así también sus relaciones con el Witz, los sueños y la formación de síntomas. Dicho campo, propio del psicoanálisis, abre una dimensión no contemplada ni por la psiquiatría ni por la psicopatología tradicional. Será en esas “pequeñeces” de la vida cotidiana donde Freud sabrá leer la lógica de los procesos inconscientes y le permitirán construir la serie de sus formaciones.

Son los trabajos freudianos los que hicieron decir a Bleuler que “le debemos exclusivamente a Freud el que haya sido posible explicar la especial sintomatología de la esquizofrenia” (BLEULER 1911, 403). Vemos aquí, nuevamente, la diferencia entre *describir* la sintomatología –tarea realizada ya por Kraepelin y algunos predecesores como Kalhbaun y Hecker– y *explicar*, ya que para ello se necesitó recurrir a las hipótesis psicopatológicas de los mecanismos freudianos tal como Bleuler lo reconoce.

En esta misma línea podemos establecer –y en especial a partir de la lectura que nos propone Lacan– que ciertos autores –ubicados por Lanteri Laura en el segundo paradigma– llevan adelante, sin embargo, importantes distinciones psicopatológicas. En especial en Francia fue muy fuerte durante las dos primeras décadas del siglo xx la búsqueda de aislar un mecanismo y un fenómeno inicial que diera cuenta de la constitución de cada forma de delirio. Incluso muchas de las denominaciones propuestas para estas entidades ponían el acento en dicho mecanismo. Así Clerambault destaca las psicosis a base de automatismo en donde el mecanismo central que da la lógica a la mayoría de los fenómenos clínicos es el automatismo mental; lo mismo ocurre

con la psicosis pasionales cuando aísla el postulado pasional. Por su parte Serieux y Capgras avanzaron en el campo de la paranoia a partir de sus trabajos sobre el delirio de interpretación, en donde se ubica –como mecanismo central operando en la producción delirante– al fenómeno interpretativo. Dupré introduce el fenómeno imaginativo como mecanismo diferencial de los delirios imaginativos. Puede notarse fácilmente que no es lo mismo denominar una entidad –por ejemplo– “demencia precoz” (lo cual describe un estado clínico) que usar un nombre como “esquizofrenia” o como “delirio de interpretación”, que aluden a un mecanismo – la esquizia o disociación, en el primer caso, el mecanismo interpretativo, en el segundo– en su designación misma. Siguiendo a Lacan podríamos señalar que estos autores –aunque no lo formularan en estos términos– han sabido situar algo crucial de la estructura y, por lo tanto, de los fenómenos elementales implicados en cada caso. Autores de los que se podría decir que han mostrado “fidelidad a la envoltura formal del síntoma” (LACAN 1966a, 60). Es en ese sentido que les reconocemos un lugar destacado en la psicopatología a diferencia de autores como Kraepelin en quien predomina el aspecto clínico descriptivo con un menosprecio explícito y activo del psicopatológico. Lo cual no quiere decir que en su obra, a pesar de su propósito de excluir las hipótesis, haya estado totalmente ausente esta dimensión y que sus distinciones –en tanto se acercan a situar algo de la estructura– no hayan abierto la puerta a sus sucesores. Según Lacan “Clérambault conocía bien la tradición francesa, pero era Kraepelin quien lo había formado, en quien el genio de la clínica era llevado a lo más alto” (LANTERI-LAURA 1998, 60).

Tal vez podríamos –para concluir– hablar de un *Paradigma lacaniano*, ya no de la psiquiatría sino del *psicoanálisis*, que puede constituir una respuesta al *impasse* del modelo del DSM y la psiquiatría contemporánea. Este se elabora a partir del modo en que Lacan produce las estructuras freudianas a partir de su lectura de Freud, dando cuenta de la envoltura formal del síntoma y su relación con el goce. Esta es su respuesta a la psicopatología, a la que subvierte y renueva, introduciendo también un debate con el pasado y el presente de la psiquiatría; es decir, una historia viva que nos concierne e interroga en nuestra práctica cotidiana y en sus consecuencias.

Bibliografía

- BEAUCHESNE, H. (1986): *Histoire de la psychopathologie*, Presses Universitaires de France, París, 1986.
- BERCHERIE, P. (1980): *Los fundamentos de la clínica. Historia y estructura del saber psiquiátrico*, Manantial, Bs. As., 1986.
- BLEULER, E. (1911): *Demencia Precoz*, Lumen, Buenos Aires, 1993.
- EY, H. (1950): "Les limites de la psychiatrie. Le problème de la psychogénèse", en *Le problème de la psychogenese des nevroses et des psychoses*, Desclée de Brower, París, 1950.
- FREUD, S. (1896): "Nuevas puntualizaciones sobre las neuropsicosis de defensa", en *Obras Completas*, Amorortu, III, Buenos Aires, 1981.
- FREUD, S. (1914): "Contribución a la historia del movimiento psicoanalítico", en *Obras Completas*, Amorortu, XIV, Buenos Aires, 1979.
- IONESCU, S. (1994): *Catorce enfoques de la psicopatología*, Fondo de Cultura Económica, México, 1994.
- JASPERS, K. (1913): *Psicopatología general*, Beta, Buenos Aires, 1980.
- KUHN, T. S. (1962): *La estructura de las revoluciones científicas*, Fondo de Cultura Económica, México, 1985.
- LACAN, J. (1932): *De la psicosis paranoica en sus relaciones con la personalidad*, Siglo XXI, México, 1979.
- LACAN, J. (1946): "Acerca de la causalidad psíquica", en *Escritos 1*, Siglo XXI, México, 1984.
- LACAN, J. (1966a): "De nuestros antecedentes", en *Escritos 1*, op. cit.
- LACAN, J. (1966b): "Presentación de la traducción francesa de las *Memorias del presidente Schreber*", en *Intervenciones y Textos 2*, Manantial, Buenos Aires, 1988.
- LACAN, J. (1973): "Introducción a la edición alemana de un primer volumen de los *Escritos*", *Uno por Uno*, N° 42, 1995.
- LANTERI-LAURA, G. (1998): *Essai sur les paradigmes de la psychiatrie moderne*, Editions du temps, París, 1998.
- MAZZUCA, R. y col. (2001): *Las psicosis. Fenómeno y estructura*, Eudeba, Buenos Aires, 2001.
- MINKOWSKI, E. (1933): *El tiempo vivido*, Fondo de Cultura Económica, México, 1968.
- POSTEL, J. (1993): *Dictionnaire de Psychiatrie et de Psychopathologie Clinique*, Larousse, París, 1993.
- SCHNEIDER, K. (1950): *Psicopatología clínica*, Paz Montalvo, Madrid, 1951.

Actualidad de la psiquiatría clásica¹

Leonardo Leibson

El propósito de este texto es definir las principales entidades clínicas acuñadas por los desarrollos de la Psiquiatría Clásica, esclareciendo las razones por las cuales estos cuadros se fueron constituyendo, para luego situar los destinos y suertes diversas que corrieron en el devenir histórico hasta llegar a la clínica actual.

Con esto apuntamos a tener una visión de conjunto de la nosografía psiquiátrica y a reconocer el alcance de cada uno de estos tipos clínicos².

I. La psiquiatría clásica, razones de su vigencia

¿Por qué plantear la actualidad de la psiquiatría clásica? Se dice que algo es clásico cuando más allá del tiempo transcurrido desde su producción, sigue provocando efectos. Así ocurre, por ejemplo, con ciertas músicas o algunos autores literarios. Son aquellas obras que se pueden seguir escuchando o leyendo, como Bach, el *Quijote* o las obras de Shakespeare. Lo clásico no necesariamente supone tiempos muy lejanos, aunque sí un cierto lapso, de al menos una o dos generaciones; por eso también decimos que Los Beatles, o Spinetta, son clásicos. Son obras que más

1 Trabajo basado en un seminario dictado a alumnos de la Cátedra II de Psicopatología de la UBA en 2005.

2 Adicionalmente, iremos ubicando y aclarando algo de la terminología que utiliza la psiquiatría, que, como cualquier disciplina, tiene su propia lengua, especialmente en lo que respecta a la definición y nominación de lo que se describe como signos y síntomas.